

蒋德铭 · 明天体检 · 必做清单 + 预测对照表 v2

v2 新增:膝关节专项 5 项(基于 2025-11 长木谷 AI 评估补入)

v2 关键更新:2025-11 长木谷膝关节 AI 评估显示你双侧膝内翻(右 180.6° / 左 178.1° ,正常 171-175°)+ 双侧关节间隙改变。

这是你长寿战略最大的隐藏威胁。明天必须新加 5 项膝关节专项检查。

体检策略:不做爱康套餐。直接去三甲「高级健康管理中心」VIP 套餐 + 5 项膝关节专项。总价 ¥10,000-17,000,1-2 天完成。

一、体检前 24-48 小时必做准备

时间	动作	为什么
体检前 7 天起	每天早晨 + 晚上各量一次血压,记录手机	诊室单次血压不准,你需要真实日常基线
体检前 3 天	不饮酒,不吃高脂大餐	GGT / ALT / TG 3 天前喝酒会污染当天结果
体检前 24 小时	避免剧烈运动	剧烈运动会升 CK / ALT,污染肝功能结果
体检前 12 小时(20:00 之后)	禁食,只喝白水	空腹血糖 / 胰岛素 / 血脂全套都需要禁食 8-12 小时
体检前 8 小时	23:00 前睡,确保 7+ 小时睡眠	睡眠不足会临时升血压 + 血糖 + 皮质醇
体检当天早晨	起床后 30 分钟内测血压;不喝咖啡,不抽烟	对照诊室血压
体检当天	带:2025-11 体检报告 + 膝关节 AI 报告 + 这份清单 + 体重数据截图	医生看历史对比才能给真建议

二、必做清单 · 按 5 个优先级(v2 新增膝关节专项)

这一节是核心。打印出来给医生看,逐项确认是否包含。

优先级 1 · 对照 2025-11 必复测 8 项(看 TLC 战果)

项目	2025-11 你的值	目标值	检查机构
24h 动态血压	诊室 137/95	< 120/80	心内科
LDL-C(低密度脂蛋白)	4.35 严重	< 1.8(Attia)	生化室
总胆固醇 TC	6.02	< 5.2	生化室
甘油三酯 TG	1.75	< 1.0	生化室
HDL-C	1.42	> 1.3	生化室
GGT(谷氨酰转氨酶)	124 严重	< 30(Attia)	生化室
ALT(谷丙转氨酶)	56	< 25	生化室
空腹血糖 FBG	6.06 临界	< 5.6	生化室
腹部彩超(脂肪肝)	中度	轻度 / 消失	超声科

优先级 2 · Attia 框架必补 6 项

项目	为什么必须做	费用
ApoB(载脂蛋白 B)	心血管真因果指标,最不能漏的一项	¥80-150
HbA1c(糖化血红蛋白)	看 3 个月平均血糖	¥30-50
空腹胰岛素 + HOMA-IR	胰岛素抵抗指数,比 HbA1c 早 5-10 年预警	¥100-200
hs-CRP	全身炎症,心血管 + Alzheimer's 双标	¥30-60
同型半胱氨酸(Hcy)	独立心血管 + 神经退行风险	¥40-80

项目	为什么必须做	费用
维 D 25(OH)D + 维 B12	国人缺乏率 70%+,减脂期更易缺	¥150-250

Lp(a) 不用再测。你 2025-11 测过 319 mg/L,一生不变。

优先级 3 · 抓肌肉流失证据 3 项

背景:7 个月减 11.2 kg 里 3.7 kg 是骨骼肌(占 33%)。健康减脂应 < 20%。

项目	为什么必须做	费用	在哪做
DXA(双能 X 线骨密度 + 体成分)	体成分金标准。看真实肌肉 / 内脏脂肪 / 骨密度 / ASMI	¥300-600	影像科
VOmax + CPET	全因死亡率最强单一预测因子	¥800-1500	运动医学中心
握力测试 + 农民走	肌肉力量最敏感指标。男 46 岁握力 < 35 kg = 警示	¥0-50	康复科

优先级 4 · 膝关节专项 5 项(v2 新加,最紧迫)

背景:2025-11 长木谷 AI 显示双侧膝内翻 + 关节间隙改变 + 高危人群。这是「边际十年崩塌」最早的红灯,比 LDL-C 4.35 还紧迫。

项目	为什么必须做	费用	在哪做
膝关节 X 光(站立位负重)+ 长木谷 AI 复测	看 7 个月减重 11.2 kg 后胫股角 / 关节间隙是否改善	¥100-300	三甲影像科
膝关节 MRI(双侧)	X 光看不到软骨;MRI 看半月板 + 软骨退化等级	¥1000-2000	三甲影像科
下肢力线 X 光(全长片)	看股骨 / 胫骨整体力线,判断是否需要矫正	¥300-500	骨科 / 运动医学
运动医学专科面诊	评估膝关节疼痛 / 活动度 / 是否需要 PRP 等治疗	挂号费	瑞金运动医学 / 复旦运动医学
下肢功能评估(单腿站立 / 蹲起 / 平衡)	量化关节稳定性基线,12 周后复测看改善	¥100-300	运动康复科

优先级 5 · 既然到三甲,顺手做的(性价比高)

项目	为什么	费用
颈动脉超声 + CIMT	「血管真实年龄」	¥200
CAC 积分(冠脉钙化 CT)	心血管结构性硬化证据	¥500-1000
APOE 基因型(一生一次)	Alzheimer's 风险基因 ε4 携带 → 风险高 3-15 倍	¥400-800
STOP-BANG 问卷 + 必要时 PSG	年日均 6h15min,BMI 23.7,曾高血压 = OSA 中风险	问卷免费;PSG ¥1000-3000
前列腺彩超 + PSA	46 岁基线;你 2025 测过前列腺 42×27×29mm 偏大	¥200-400

优先级 6 · 可以省的(明确告诉医生不做)

项目	为什么省
Lp(a)	2025-11 已测 319,一生不变
肿瘤标志物全套	上次全部正常,不到 1 年无需重复
心电图(无症状下)	上次正常,1-2 年做一次
甲状腺彩超	上次正常,2-3 年做一次
微量元素套餐 / 杂七杂八抗体套餐	体检常推但临床价值低

三、12 项预测对照表(v2 加入膝关节)

基于你 7 个月 TLC 数据,我对明天关键指标做出预测。数据出来后填实际值 + 命中,我们一起复盘。

#	指标	2025-11 起点	我的预测	实际值	命中?
1	LDL-C	4.35	2.5-3.5	_____	☐
2	GGT	124	50-80	_____	☐
3	ALT	56	30-45	_____	☐
4	空腹血糖	6.06	5.5-5.9	_____	☐
5	TC 总胆固醇	6.02	4.5-5.5	_____	☐
6	TG 甘油三酯	1.75	1.0-1.4	_____	☐
7	HDL-C	1.42	1.3-1.6	_____	☐
8	血压(动态平均)	诊室 137/95	125-135 / 80-88	_____	☐
9	脂肪肝	中度	轻度 / 消失	_____	☐
10	DXA 内脏脂肪等级	未测	1 级(显著改善)	_____	☐
11	DXA ASMI(肌肉量指数)	未测	偏低	_____	☐
12	VOmax	未测	中等偏下	_____	☐
13	胫股角 右 / 左	180.6° / 178.1°	180-181° / 177-178° (基本不变)	_____	☐
14	关节间隙改变	双侧改变	双侧改变(无逆转)	_____	☐
15	膝关节 MRI 软骨退化等级	未测	K-L 1-2 级	_____	☐

命中规则: ≥ 10 项 $\rightarrow$ TLC 方向完全正确; 7-9 项 $\rightarrow$ 大方向对, 有 2-3 处需修; < 7 项 $\rightarrow$ 需全面审视方案。

膝关节 3 项的特别说明: 胫股角和关节间隙 12 个月内基本不会逆转, 如果出现改善是惊喜; 不改善是预期。关键看 MRI 软骨退化等级。

四、面诊医生时间的 10 个关键问题(v2 新加 3 个膝关节)

三甲医生默认每个病人 5-10 分钟。你必须主动提问。下面 10 个问题打印出来,把医生回答写在右栏。

#	问题(直接问医生)	医生回答 / 笔记
1	我的 ApoB 是多少?按 Attia / Mayo 长寿门诊标准我该不该用他汀?	_____
2	我 HOMA-IR 是多少?是否已胰岛素抵抗?要不要二甲双胍?	_____
3	我血压家用 7 天平均是 _____,需要立刻用降压药吗?	_____
4	我 DXA 显示骨骼肌量 _____,ASMI 是 _____。是肌少症前期吗?	_____
5	我 VOmax 是 _____ mL/kg/min,同龄男性什么水平?	_____
6	脂肪肝是中度还是轻度?需要做 FibroScan 吗?	_____
7	膝关节 MRI 显示 K-L 等级是几级?半月板有损伤吗?	_____
8	我双侧膝内翻 + 关节间隙改变,需要膝关节矫形矫具或注射 PRP 吗?	_____
9	我接下来 12 周做力量训练,哪些动作必须禁忌?	_____
10	下次复查的时间表?哪些 3 个月 / 6 个月 / 12 个月各复测一次?	_____

五、体检完成后立即要做的 3 件事

#	动作	时间窗	为什么
1	把所有数据填进预测对照表 + 12 项指标矩阵(对照 2025-11)	拿到报告当天	看 7 个月真实战果
2	预约 3 个面诊:心内科(他汀) + 内分泌科(二甲双胍) + 运动医学(膝盖)	1 周内	高危指标必须专科面诊
3	启动「12 周长肌肉 + 减脂」方案 v2(已包含膝内翻专项调整)	本周末	肌肉流失 + 膝盖红灯都一刻不能拖

v2 给你的一句话:你 7 个月减了 11.2 kg、脂肪率从 27.4% 降到 20.9%,客观成绩在 99% 中年男性之上。但 2025-11 那次体检里有 2 个红灯被埋藏了 7 个月没人发现:① 3.7 kg 肌肉流失(33% of 减重)② 双侧膝内翻 + 关节间隙改变。明天体检是你纠正这两个红灯的唯一窗口。

本清单 v2 基于:2025-11 爱康体检 + 2025-11 长木谷膝关节 AI + 2025-11 至 2026-05 体重管理数据 + Outlive《超越百岁》框架 + NCEP TLC 指南。不是医疗诊断,具体用药 / 用量必须主诊医师面诊后决定。